حسام صلاح | تحديث حالة سرطان المثانة

صفحة واحدة | مراجعة الخزعة والإرشادات الدولية حتى 9 أكتوبر 2026

النتيجة المؤكدة في الخزعة المراجعة

تقرير معهد وارث الصادر في 15 سبتمبر 2026: سرطان حليمي ظهاري بولي منخفض الدرجة، مرحلة pT1؛ غزا النسيج الضام تحت البطانة. عضلة المثانة موجودة وخالية من الورم في العينة، ولم يشاهد غزو وعائي/لمفاوي أو عصبي. هذا سرطان غير غاز للعضلة في العينة، لكنه ليس Ta. التقرير يسبق عملية 6 أكتوبر ولا يمثل نتيجتها.

الخطوة التالية: نتيجة إعادة الاستئصال أولا

في موعد 13 أكتوبر الظاهر بأوراق الخروج، بعد تأكيده، اطلب خزعة عملية 6 أكتوبر وتقرير الجراح: هل بقي ورم؟ وما مرحلته ودرجته؟ إعادة الاستئصال موصى بها في T1 حتى مع وجود عضلة سليمة، عادة خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع من الاستئصال الأول. راجع أيضا حجم الورم وعدده واكتمال استئصاله ووجود ورم مسطح عالي الدرجة (CIS)؛ غيابه غير موثق في الخزعة المقدمة. [1]

مسار العلاج بحسب الخطورة والنتيجة الجديدة

تختلف تصنيفات T1 منخفض الدرجة؛ وفي EAU تعتمد الخطورة على الحجم والعدد وCIS والنكس أيضا. لا يكفي العمر أو انخفاض الدرجة لتثبيت فئة الخطورة. إذا صنفها الفريق منخفضة الخطورة بعد استئصال كامل، فقد تكفي المتابعة والعلاج الموضعي المناسب؛ وللخطورة المتوسطة يناقش ميتومايسين داخل المثانة أو BCG مع صيانة سنة. [2، 3، 4]

إذا ظهرت خطورة عالية، يناقش BCG: ست جرعات أسبوعية ثم صيانة من سنة إلى ثلاث سنوات. يبدأ بعد التعافي، وبعد أسبوعين على الأقل من الاستئصال، مع تجنب إعطائه عند دم ظاهر أو التهاب بول بأعراض. بقاء T1 عالي الدرجة أو ظهور غزو العضلة يستدعي تقييم فريق أورام وخيارات أقوى، وقد تشمل إزالة المثانة؛ التقرير الحالي وحده لا يوجبها. [3]

مستجدات 2026: كيف تؤثر في القرار؟

تحديث AUA/SUO صدر في سبتمبر 2026، وإرشاد NCCN المنشور في 2026 يؤكد مسار التقييم والعلاج لمرض غير غاز للعضلة. دراسة أسترالية تبناها eviQ تتيح BCG مع ميتومايسين لتقليل استهلاك BCG، لكنها لم تثبت تفوق الجمع. دراسة يابانية تدعم مراقبة منتقاة لـT1 عالي الدرجة بعد استئصال ثان سلبي، لكنها قارنت BCG دون صيانة؛ لا تعمم على حالتك تلقائيا. [5، 6، 7، 8]

أول منظار متابعة عادة بعد ثلاثة أشهر؛ ناقش يناير 2027 إذا اعتمد الطبيب استئصال أكتوبر بداية. ثم يحدد الجدول بحسب الخطورة، ولا تحسب نسبة شفاء شخصية دون البيانات الناقصة. للطوارئ عند احتباس البول أو نزف غزير وخثرات أو حرارة وقشعريرة. [9، 10]

المصادر المختصرة (روابط قابلة للنقر)

[1] EAU 2026: إعادة الاستئصال

[2] EAU 2026: تصنيف الخطورة

[3] EAU 2026: العلاج والسلامة

[4] NICE البريطاني: NG2

[5] AUA/SUO: 2026 تحديث سبتمبر

[6] NCCN: 2026 الإرشاد المنشور

[7] أستراليا: eviQ، بروتوكول 2026

[8] اليابان: JCOG1019، دراسة 2026

[9] EAU 2026: المنظار والمتابعة

[10] NHS: التعافي وعلامات الخطر

نطاق المراجعة: أبرز المصادر الدولية المفتوحة؛ AUA/NCCN من الملخصات المتاحة. نسخة محدثة بالخزعة؛ تقرير تثقيفي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والقرار لطبيب المسالك وفريق الأورام.